Volume 1

Pagina 9 – livello di progetto definito per la Fase 1 e Fase 2

“Si precisa che l’attuale livello di definizione del PFTE2 risulta differenziato tra la fase 1 e la fase 2. La fase 1 presenta, sotto il profilo progettuale — edilizio, strutturale, impiantistico e cantieristico — un livello di dettaglio più avanzato rispetto alla fase 2, che al momento è sviluppata solo in termini di ordini di grandezza, pur includendo contenuti funzionali all’intero intervento.”

Pagina 9 – spiega le differenze tra PFTE1 e PFTE2

“Il presente progetto è da considerarsi come naturale prosecuzione del processo avviato nel mese di febbraio 2024 secondo le disposizioni del precedente Codice degli Appalti Pubblici (di seguito denominato PFTE1). Tale processo è successivamente transitato nell’ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e, a seguito di tale passaggio, sarà d’ora in avanti identificato come PFTE2”

Pagina 14 – fattori sulla scelta tra nuovo e riqualificazione

“A seguito di una valutazione approfondita, sono stati identificati due possibili scenari: ristrutturazione o sostituzione edilizia.
Analisi dettagliate condotte dall'ASST di Cremona, in collaborazione con le Direzioni e Strutture regionali competenti, hanno rivelato che la ristrutturazione richiederebbe un investimento significativo senza garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di funzionalità, adeguatezza e sostenibilità.”

Pagina 16 – tabella incontri tra enti PFTE1 – Conferenza dei Servizi preliminare – PFTE2

Pagina 26 - parametri urbanistici definiti nell’ambito del PFTE2

“1. VERIFICA SUPERFICIE TERRITORIALE (ART. 5.1 Piano delle Regole Disposizioni attuative - Superficie territoriale (St)). È la superficie complessiva degli ambiti per i quali si prevede la formazione di strumenti urbanistici attuativi, calcolata al lordo delle strade e degli spazi pubblici già esistenti o da realizzare, che ricadono entro gli ambiti stessi: → 196.561 m2

2. VERIFICA RAPPORTO DI COPERTURA (ART. 5.3.1 Piano delle Regole Disposizioni attuative – Superficie coperta (Sc)). È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale, definita dalla quota più depressa tra il piano di campagna di progetto e la sede stradale, delle parti edificate o da edificarsi. Superficie coperta / Superficie Territoriale: → [(funzioni pubbliche 9.400 m2 + ospedale 30.967 m2 + polo tecnologico 3.816 m2) / 196.561 m2] % = 22,47 % della superfice territoriale.

3. VERIFICA SUPERFICIE A VERDE PROFONDO (nel parco) Aree definite da opere a verde permeabili al 100%: → 72.461 m2, ossia 36,86 % della superfice territoriale.

4. VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE (nel parco) (ART. 5.4.1 Piano delle Regole Disposizioni attuative - Superficie permeabile (Sp)). È la parte di Superficie fondiaria d'ogni intervento che non

deve risultare compromessa da costruzioni in soprassuolo o nel sottosuolo o da pavimentazioni impermeabili e deve essere sistemata a verde:

• RAPPORTO SUPERFICIE PERMEABILE Sp / St: → [(73.643 m2) / 196.561 m2) % = 37,46 % della superfice territoriale;

• RAPPORTO SUPERFICIE SEMIPERMEABILE (Ssp) Ssp / St: → (48.126 m2 / 196.561 m2) % = 24,48 % della superfice territoriale;

• VERIFICA PERMEABILITÀ DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE secondo i Criteri Ambientali Minimi (Sp+Ssp)/ST > 62% della superfice territoriale.

5. SUPERFICIE IMPERMEABILE (nel parco) →12.695 m2, ossia 6,45 % della superfice territoriale."

Pagine 30 e 31 – conferma spezzettamento progetto

"Come precedentemente descritto, il polo ospedaliero comprenderà la realizzazione di un nuovo edificio localizzato nella porzione nord del comparto, dove è prevista l'attivazione di nuove funzioni di interesse generale e servizi per una superficie lorda complessiva di 2.656 m2, suddivisa e declinata nelle seguenti funzioni:

• area destinata ad asilo avente superficie pari a 728 m2;

• area destinata ad altri servizi **ipotizzati** per superficie pari a 1.928 m2: hospice e servizi generali, formazione e ricerca, biblioteca, residenze temporanee e spazio per famiglie.

Si sottolinea che la progettazione di tale fabbricato **non è inclusa** nel presente progetto di PFTE2 e sarà integrata in fasi successive. Si allega **a titolo illustrativo** lo schema dove è localizzabile il fabbricato servizi."

Pagina 35 – aggettivo chiave dello spezzettamento del progetto "eventuale"

"In un successivo momento, una volta completato tutto il progetto del nuovo polo ospedaliero, comprensivo anche della nuova ala a nord con nuove funzioni e a seguito della riqualificazione dell'asse di via Cà del Ferro, oltre agli accessi previsti lungo via Giuseppina che restano invariati rispetto a quanto sopra descritto, verranno realizzati anche due nuovi accessi lungo il lato nord del lotto come rappresentato nella successiva Figura 2.2-7.

In particolare, nella configurazione finale oltre agli accessi precedentemente elencati, si considerano anche i seguenti:

• accesso D: ulteriore accesso al parcheggio interrato -1 riservato agli addetti dell'ospedale;

• accesso E: accesso a un **eventuale** nuovo parcheggio interrato previsto nell'area nord del comparto ospedaliero,

a servizio anche delle nuove funzioni che si insedieranno.

Rispetto alla fase di intervento parziale, a seguito della riqualificazione dell'asse nord di via Cà del Ferro e degli ulteriori accessi previsti lungo tale viabilità, oltre all'accesso B posizionato lungo via

Giuseppina gli addetti potranno utilizzare anche l'accesso a loro dedicato lungo tale asse (accesso D in Figura 2.2-7). Quindi è ipotizzabile che gli addetti proveniente o diretti verso nord (viale Concordia) utilizzeranno prevalentemente l'accesso lungo via Ca' del Ferro, mentre gli addetti provenienti da altre direttrici continueranno ad usufruire dell'accesso localizzato lungo via Giuseppina. Il parcheggio di **futura** realizzazione previsto nell'area nord e accessibile tramite l'accesso indicato con la lettera E nell'immagine precedente garantirà un'ulteriore offerta di sosta per addetti e/o pazienti oltre agli utenti delle nuove funzioni che ivi si insedieranno."

Pagina 38 – descrizione fasi 1 e 2 (manca la demolizione di monoblocco ospedaliero attuale e dei 12 edifici circostanti)

"Nella fase 1 sono incluse le seguenti aree di intervento:

• Polo Ospedaliero principale, comprensivo di tutte le strutture e impianti

• Complesso Tecnologico

• Parcheggio interrato

• Viabilità interna ed esterna

Nella fase 2 sono incluse le seguenti aree di intervento:

• Polo ospedaliero secondario

• Area Centrale

• Anello Rurale"

Pagina 43 – progetto di derivazione acque sotterranee e non pertinenza attuale ma rimandata a fase successiva (spezzettamento del progetto e delle procedure ambientali)

"Il prelievo di 216 l/s configura un possibile progetto di grande derivazione (ossia una derivazione con portata di punta superiore a 100 l/s). Considerato il livello di approfondimento progettuale necessario per i pozzi — non pertinente all'attuale fase del PFTE — e con riferimento alla D.G.R. X/3826 del 14 luglio 2015, che ha aggiornato gli allegati alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, la derivazione in oggetto, una volta definita con adeguato dettaglio progettuale, sarà sottoposta a una specifica procedura PAUR di competenza regionale."

Pagina 45 - progetto parcheggio nord in fase preliminare (spezzettamento del progetto)

"al di sotto del fabbricato nord un parcheggio, la cui attuale progettazione si trova ancora in una fase preliminare.

Tale parcheggio servirà a garantire un'ulteriore offerta di sosta per addetti e pazienti esterni e sarà caratterizzato da almeno 700 posti auto al fine di garantire il fabbisogno complessivo di sosta."

Pagina 48 – sempre riferimento al parcheggio nord

"Altri circa 700 posti auto sono previsti in struttura al di sotto della sagoma dell'edificio nord. Tale intervento riguarda la fase 2, attualmente non sviluppata compiutamente come la fase 1.

Attualmente la progettazione di questa area di sosta si trova ancora in una fase preliminare, ma tale parcheggio offrirà una capacità sufficiente per soddisfare il fabbisogno di visitatori e utenti delle varie funzioni, oltre a garantire un'ulteriore offerta per addetti e pazienti esterni. Ai fini delle analisi, si è considerato che tale parcheggio interrato sia caratterizzato da un'offerta di circa 700 posti auto, valore minimo da garantire affinché il fabbisogno complessivo di sosta sia soddisfatto."

Pagina 56 – durata della realizzazione del nuovo ospedale di Cremona (oltre 10 anni!) – fase 2 ancora da definire! E la demolizione del monoblocco non viene citata nel cronoprogramma!

"Il cronoprogramma complessivo dei lavori consta di complessivi **3.970 giorni**, ossia **10,8 anni**. Il cronoprogramma complessivo è suddiviso in 2 fasi macro:

• fase 1: durata di circa **6 anni** (2.230 giorni, fase 1)

• fase 2: durata di circa **4,7 anni** (1.740 giorni, fase 2).

Sia la fase 1 che la fase 2 sono suddivise in sottofasi di lavoro specifiche per aree di intervento, lavorazioni e tempistiche, così come dettagliate nell'elaborato "CRONOPROGRAMMA - POC24_D_00001_G_GE_GE_CR_0".

All'interno del cronoprogramma, le attività specificatamente dedicate alla realizzazione del parcheggio sono racchiuse nella fase 1 e, più precisamente concentrate nelle sottofasi che vanno dalla 1.11 alla 1.15 così come riportato nell'estratto seguente. E' stimata per le sottofasi da 1.11 a 1.15 una durata complessiva di 740 giorni.

Più specificatamente nelle sottofasi 1.11+1.12 verranno eseguiti gli scavi espressamente dedicati ai parcheggi per un volume stimato pari a 112.251,95 m3, così come meglio specificato di seguito.

Mentre, nella sottofase 2.01, si prevede l'esecuzione degli scavi per la realizzazione del parcheggio da 700 posti auto, situato al di sotto dell'edificio nord destinato ai servizi (polo ospedaliero secondario).

Per le attività della sottofase 2.01, si prevede un volume di scavo stimato pari a circa 47.000 m^3 e una durata di 360 giorni.

A fini cautelativi, è stato considerato anche questo volume, sebbene di carattere indicativo e coerente con l'attuale livello di sviluppo progettuale e di cantierizzazione degli interventi previsti nella fase 2, la cui definizione risulta meno avanzata rispetto a quella della fase 1."

Pagina 59 – viene citata la demolizione del vecchio ospedale, demolizione che comprende sia il monoblocco a forma di "H" di 11 piani complessivi e i dodici edifici circostanti, come facente parte del progetto del nuovo ospedale, ma non si descrivono metodi, volumi di macerie e caratterizzazione e differenziazione dei vari materiali per il corretto smaltimento o riciclaggio, mezzi d'opera e incidenza sul traffico e sulla viabilità pubblica, e i tempi per eseguire tale operazione che non si notano nel cronoprogramma.

Operazione propedeutica e necessaria per la realizzazione di parcheggi e funzioni pubbliche previsti nella Fase 2. Senza queste importanti demolizioni non si può cantierare la fase 2.

Pagina 65 – riferimenti alla programmazione sanitaria regionale (scelta di nuovo ospedale anziché riqualificare l'esistente)

Pagina 100 – impatto dei pozzi per geotermia (12 per prelievo e 12 per resa)

"Nel caso specifico, considerato che il prelievo medio annuo è >100 l/s, l'impatto causato dalla derivazione al corpo idrico sotterraneo è da ritenersi RILEVANTE."

Pagina 105 – impatto derivazione dai corpi idrici sotterranei

"Nello studio in esame la criticità è di tipo Rilevante considerati i prelievi medi >100 l/s ed una criticità di tipo E-Esclusione, nel quale le nuove derivazioni non sono compatibili, fatte salve quelle destinate all'uso potabile e all'uso geotermico con integrale restituzione a cui è applicabile la procedura di deroga prevista dall'art.4.7 della DQA."

Pagina 135 – impatto causato dalla derivazione al corpo idrico sotterraneo

"In riferimento all'intervento in esame e alle strategie energetiche adottate, in riferimento alla geotermia, il prelievo medio annuo è >100 l/s, l'impatto causato dalla derivazione al corpo idrico sotterraneo è da ritenersi RILEVANTE. Nello studio in esame la criticità è di tipo Rilevante considerati i prelievi medi >100 l/s ed una criticità di tipo E-Esclusione, nel quale le nuove derivazioni non sono compatibili, fatte salve quelle destinate all'uso potabile e all'uso geotermico con integrale restituzione a cui è applicabile la procedura di deroga prevista dall'art.4.7 della DQA. Sulla base dei fabbisogni appresso indicati, la portata di punta necessaria per uso prevalente scambio termico è pari a 300 l/s e la portata media annua, definita come "*valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo ed il periodo nell'arco dell'anno solare per il quale il prelievo è concesso*" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera x) del R.R. n. 2/2006, è pari a 216 l/s.

Con riferimento alla *D.G.R. X/3826 del 14 luglio 2015*, che ha aggiornato gli allegati alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, la derivazione in oggetto, con portata DI PUNTA > 100 L/S ricadendo nell'allegato A "*progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all' art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2" (allegato alla l.r. 5/2010),* punto *b2)* Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. *(Grandi derivazioni di cui al* R.R. 2/2006*) "* necessita l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Trattandosi di grande derivazione (216 l/s), la competenza è in capo a Regione Lombardia.

La specifica procedura PAUR per la valutazione della grande derivazione seguirà la seguente, in considerazione del necessario livello di approfondimento progettuale dei pozzi che non attiene l'attuale fase del PFTE."

Pagina 196 – prescrizioni geologiche e sismiche

"Nello studio geologico di supporto al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremona, l'ambito di studio è compreso all'interno della Classe di fattibilità geologica 3, Sottoclasse 3.1- Aree esondabili o allagabili da Reticolo Secondario di Pianura "consortile" a pericolosità idraulica "media o moderata" H1-H2.

Le trasformazioni da effettuarsi in questa sottoclasse di fattibilità dovranno prevedere approfondimenti basati sul livello di pericolosità attuale dell'area. Le richieste di intervento edilizio o trasformazione di qualunque tipo, oltre alla documentazione geologica e tecnica già prevista dalla normativa, dovranno essere integrate da una esaustiva relazione tecnica, firmata da un geologo o ingegnere idraulico, che descriva lo stato di efficienza delle opere di mitigazione del rischio che garantiscono i modesti livelli attuali di pericolosità delle aree. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere progettati considerando misure e accorgimenti atti alla mitigazione del rischio idraulico, facendo riferimento a quanto presente nell'All.4 alla d.g.r. 2616/2011 e al Punto 3.5.3 della d.g.r. 6738/2017.

Secondo la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, di cui alla recente D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 "*Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia*", il comune di Cremona risulta riclassificato in Zona Sismica 3 con valore di accelerazione massima Agmax = 0.054655. Pertanto, ai sensi della l.r. 12 ottobre 2015 n. 33 è necessario depositare allo sportello unico del comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di progetto conforme ai contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001."

Volume 2

Pagina 196 - 199 – Conclusioni

"Il presente documento costituisce lo Studio Preliminare Ambientale (nel seguito SPA) posto a corredo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, avente ad oggetto il progetto dei parcheggi, in struttura e in superficie, del Nuovo Ospedale dei Cremona.

Ad oggi la normativa ambientale vigente (D.Lgs. 152/2006 smi e LR 5/2010 smi) non include gli insediamenti ospedalieri tra le tipologie di opere da assoggettare a qualsivoglia valutazione ambientale. Tuttavia, l'Ospedale previsto all'attuale grado di definizione progettuale permette di identificare alcune singole opere previste per il funzionamento del complesso ospedaliero, che sono invece riconducibili a categorie specifiche.

Tra le opere necessarie alla sua realizzazione e funzionamento vi sono il progetto di parcheggi, in superficie e in struttura, per capacità complessiva superiore a 500 posti auto. Tale tipologia di opera, ai sensi della LR 5/2010 e smi, è sottoposta alla Verifica di Assoggettamento a VIA di competenza comunale. La casistica di riferimento è la seguente: Allegato B, punto 7), b5) Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto.

In particolare, il numero di posti auto previsti dal PFTE2 è pari a 1.879 posti auto, così distribuiti:

• Nuovi parcheggi in struttura sotterranea, per complessivi n. 1.540 posti auto;

• Adeguamento di aree sosta esterne in superficie, per n. 174 posti auto;

• Mantenimento di aree sosta esterne in superficie, per n. 165 posti auto.

Allo stato attuale l'offerta della sosta è composta da 1.640 posti auto correlati all'Ospedale, di cui:

- 989 interni al comparto ospedaliero;

- 283 presenti in largo Priori Emilio;

- 368 presenti nelle vie perimetrali (Cà del Ferro, Giuseppina e Concordia).

L'intervento tra nuovi posti auto e adeguamenti vari introduce quindi 239 posti auto aggiuntivi netti.

Il sistema della sosta interna al comparto ospedaliero comprende poi anche 34 posti auto nell'area di sosta esclusivamente dedicata al pronto soccorso e 3 posti dedicati alle ambulanze.

L'ambito in esame è l'attuale area ospedaliera ricadente nelle Polarità Urbane di Primo livello del PTCP e nel "Centro Abitato – TUC", tra le zone CER 8 Ambiti specialistici "Aree ed attrezzature per servizi, esistenti e confermati".

L'area di progetto si trova tra l'espansione urbana di Cremona e due sistemi ambientali: la bassa pianura padana irrigua, con la sua "cintura agricola" di campi coltivati a nord, e l'ambito fluviale del Po, modellato dal fiume e dai corsi d'acqua secondari. Si evidenzia come l'ambito di analisi sia posto in prossimità dell'autostrada A21 che collega la città di Cremona a Brescia e Piacenza.

Per quanto riguarda la coerenza con il quadro programmatico territoriale e ambientale non si rilevano elementi di contrasto e criticità tra lo stato attuale e lo pianificatorio sancito dagli strumenti di pianificazione ai vari livelli, rispetto alla proposta di intervento,

L'area oggetto di intervento, si trova al di fuori di aree protette e/o appartenenti al sistema Rete Natura2000, è non è incluso in areali della RER.

L'ambito in esame non è interessato da formazioni forestali oggetto della disciplina del PIF.

L'intervento in esame è coerente con i principi di riduzione del consumo di suolo e di contenimento del carico urbanistico perseguiti dalla Lr 31/2014 e dal PTR ad essa adeguato, in quanto la proposta di progetto interessa l'ambito che già ospita l'ospedale cittadino e l'intervento è in la sostituzione dell'attuale edificio con uno nuovo.

L'ambito in esame non presenta vincoli alla trasformabilità dei suoli, con l'indicazione però di "Attenzione Archeologica" (art. 44).

Dalle analisi e dalle valutazioni ambientali condotte emerge che, il sito ricade infatti in uno scenario di pericolosità idraulica medio-bassa (H1–H2) e in Classe di fattibilità geologica 3.1, condizioni che

richiedono l'adozione di misure di mitigazione conformi alle D.G.R. 2616/2011 e 6738/2017, pienamente integrate nel progetto. Il sistema geotermico previsto comporta prelievi superiori a 100 l/s, configurando una grande derivazione soggetta a procedura di VIA regionale. Le modellazioni idrogeologiche attualmente disponibili indicano abbassamenti piezometrici max ~4 m, con soglia 1 m a ~500 m e disturbi termici limitati, non interferenti con pozzi terzi. Tali esiti saranno verificati e validati nelle prove di collaudo.

Dal punto di vista viabilistico, l'area risulta ben collegata alla rete infrastrutturale esistente, a partire dalla prossimità con lo svincolo "Cremona" dell'autostrada A21 e comprese le principali connessioni extraurbane. Le nuove configurazioni di accesso e gli interventi sulla viabilità circostante garantiscono buoni livelli di servizio in tutti gli scenari analizzati, sia parziali che completi, con variazioni di flusso concentrate su via Giuseppina e via Ca' del Ferro, comunque pienamente gestibili grazie alle nuove sezioni stradali e alla rotatoria prevista.

Anche gli effetti sulla qualità dell'aria risultano modesti. Le emissioni indotte risultano contenute:

- Incrementi percentuali rispetto allo stato di fatto:
    - o +6–7% nello scenario parziale (INT1)
    - o +8–10% nello scenario completo (INT2)
- Contributo sul totale comunale:
    - o <0,27% rispetto alle emissioni da traffico
    - o <0,08% rispetto alle emissioni complessive

Le emissioni di polveri da cantiere (PM10), calcolate secondo linee guida ARPA Toscana, sono inferiori alle soglie di compatibilità anche per gli scenari peggiori.

Per la componente acustica, le simulazioni mostrano impatti contenuti grazie all'adozione di misure di mitigazione quali arretramento delle sorgenti impiantistiche, installazione di schermature, utilizzo di macchinari a basse emissioni e realizzazione di una barriera acustica dedicata verso i ricettori sensibili. Nelle condizioni di esercizio ordinario, il rispetto dei limiti normativi risulta garantito.

Sul piano paesaggistico, l'intervento si configura come una rigenerazione interna all'area già edificata, mantenendo la funzione ospedaliera senza consumo di nuovo suolo. La nuova configurazione dell'edificio favorisce la permeabilità visiva, una significativa ricomposizione degli spazi aperti e una migliore integrazione con il contesto, mentre lo spostamento dei parcheggi in struttura interrata consente di liberare superfici da destinare al Parco della Salute, quale attuazione della rete ecologica locale. Per quanto riguarda vegetazione, fauna ed ecosistemi, il progetto non presenta interferenze con siti Natura 2000, distanti oltre 3,8 km, e gli impatti risultano trascurabili sia in fase di cantiere sia in esercizio, come indicato dalle linee guida regionali sulla biodiversità. Gli interventi previsti, tra cui il Parco della Salute, il Bosco climatico, l'Anello vitale e l'Anello rurale, contribuiranno anzi al rafforzamento della continuità ecologica.

Il complesso delle analisi e delle valutazioni condotte permette di valutare che il progetto relativo ai parcheggi del nuovo Ospedale di Cremona è compatibile con il contesto territoriale, ambientale e pianificatorio.

Gli impatti sono generalmente non rilevanti o trascurabili, mentre si rilevano effetti migliorativi sul paesaggio locale, sul verde e sulla qualità dell'organizzazione urbana complessiva.

Si precisa quanto segue per la grande derivazione geotermica, da attivarsi con il livello progettuale successivo.

In riferimento all'intervento in esame e alle strategie energetiche adottate, in riferimento alla geotermia, il prelievo medio annuo è >100 l/s, l'impatto causato dalla derivazione al corpo idrico sotterraneo è da ritenersi RILEVANTE. Nello studio in esame la criticità è di tipo Rilevante considerati i prelievi medi >100 l/s ed una criticità di tipo E-Esclusione, nel quale le nuove derivazioni non sono compatibili, fatte salve quelle destinate all'uso potabile e all'uso geotermico con integrale restituzione a cui è applicabile la procedura di deroga prevista dall'art.4.7 della DQA.

Sulla base dei fabbisogni appresso indicati, la portata di punta necessaria per uso prevalente scambio termico è pari a 300 l/s e la portata media annua, definita come "*valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo ed il periodo nell'arco dell'anno solare per il quale il prelievo è concesso*" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera x) del R.R. n. 2/2006, è pari a 216 l/s.

Con riferimento alla *D.G.R. X/3826 del 14 luglio 2015*, che ha aggiornato gli allegati alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, la derivazione in oggetto, con portata DI PUNTA > 100 L/S ricadendo nell'allegato A "*progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all' art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2" (allegato alla l.r. 5/2010),* punto *b2)* Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. *(Grandi derivazioni di cui al* R.R. 2/2006*)"* necessita l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Trattandosi di grande derivazione (216 l/s), la competenza è in capo a Regione Lombardia.

La specifica procedura PAUR per la valutazione della grande derivazione seguirà la seguente, in considerazione del necessario livello di approfondimento progettuale dei pozzi che non attiene l'attuale fase del PFTE."